



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

TERM OF REFERENCE (TOR)
MANAGEMENT RISIKO (MANRISK)
TAHUN 2025



**TERM OF REFERENCE (TOR)
DIKLAT MANAJEMEN RISIKO (MANRISK)
TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa "Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki unit layanan yang seluruhnya bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan mengutamakan keselamatan pasien". Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017 nomor 11 tentang Keselamatan Pasien pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa "Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil". Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pasal 2 yakni "Pengaturan Keselamatan Pasien bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan melalui penerapan manajemen risiko dalam seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan."

Rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas, yaitu dengan cara memperhatikan pemberian pelayanan kesehatan dalam hal keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja yang meliputi identifikasi, asesmen dan pengelolaan risiko untuk meminimalisir risiko dan cedera yang tidak diinginkan (Fanny & Soviani, 2020). Risiko adalah bagian integral dari kehidupan manusia, karena setiap kegiatan yang dilakukan pasti mempunyai beban dan risiko yang ditanggung. Risiko juga didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya sesuatu yang berakibat buruk dan merugikan (Darmawi, 2017). Agar risiko tidak menghalangi kegiatan pemberian pelayanan kesehatan maka rumah sakit perlu menerapkan program manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Pada bidang kesehatan, konsep manajemen risiko diterapkan guna menghasilkan pelayanan kesehatan yang berkualitas karena merupakan hak bagi setiap pasien dan seluruh masyarakat di instansi kesehatan, hal ini memacu para penyelenggara pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit untuk secara serius berupaya meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan mutu pelayanan kesehatan adalah suatu langkah ke arah peningkatan pelayanan kesehatan baik untuk individu maupun untuk populasi sesuai dengan hasil yang diharapkan dan sesuai dengan pengetahuan profesional terkini. Untuk mencapai mutu pelayanan kesehatan yang baik maka rumah sakit membutuhkan sebuah manajemen risiko.

1.2. Dasar Hukum



1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/SK/VI/1993 tentang penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.

1.3.Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Manajemen risiko rumah sakit bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko kerugian dan cedera yang mungkin terjadi. Manajemen risiko juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.

2. Tujuan

- a. Meminimalkan risiko kematian, cedera, dan penyakit
- b. Meningkatkan hasil asuhan pasien
- c. Mengelola sumber daya secara efektif
- d. Mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan
- e. Menurunkan angka infeksi
- f. Melindungi aset reputasi Rumah Sakit

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Susunan Panitia

NO	SUSUNAN PANITIA	NAMA	TUGAS
1	Ketua Panitia	Faisal Aminuddin Ilham, S.KM	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara.
2	Sekretaris	Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi	Bertanggung jawab terhadap pendokumentasian seluruh dokumen dan notulen
3	Bendahara	Keuangan	Bertanggung jawab terhadap anggaran dana Diklat
4	Sie Dokumentasi	Maja Tito Sadewo, S.Kom	Bertanggung jawab terhadap dokumentasi Diklat
5	Sie Penunjang	Erik Ardianata	Bertanggung jawab mengkoordinir peserta untuk patuh dengan jadwal pelatihan.

2.2 Rencana Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tanggal : 22 – 23 April 2025
- b. Pukul : 09.00 – 10.30 (Gelombang 1)
11.00 – 12.30 (Gelombang 2)
- c. Tempat : Hall Sakura Lt. 5 RS Prima Husada Malang

2.3 Rencana Rapat Panitia Penyelenggaraan

- a. Tanggal : Selasa, 03 Maret 2025
- b. Pukul : 10.00 WIB
- c. Tempat : Kantor Manajemen



2.4 Sasaran atau Peserta

- a. Seluruh Staf RS Prima Husada sejumlah 410

2.5 Susunan Acara Lengkap

NO	JAM	DURASI	MATERI/KEGIATAN	PETUGAS
Gelombang 1 (09.00-10.30 WIB)				
1	09.00-09.05 WIB	5 menit	Absensi pertama by fingerprint	SDM
2	09.05-09.10 WIB	5 menit	Pembukaan dan pre-test	SDM
3	09.10-10.00 WIB	50 menit	Materi	Faisal Aminuddin Ilham, S.KM
4	10.00-10.20 WIB	20 menit	Diskusi dan tanya jawab	SDM & Faisal Aminuddin Ilham, S.KM
5	10.20-10.25 WIB	5 menit	Penutupan dan post-test	SDM
6	10.25-10.30 WIB	5 menit	Absensi kedua by fingerprint	SDM
Gelombang 2 (11.00-12.30 WIB)				
1	11.00-11.05 WIB	5 menit	Absensi pertama by fingerprint	SDM
2	11.05-11.10 WIB	5 menit	Pembukaan dan pre-test	SDM
3	11.10-12.00 WIB	50 menit	Materi	Faisal Aminuddin Ilham, S.KM
4	12.00-12.20 WIB	20 menit	Diskusi dan tanya jawab	SDM & Faisal Aminuddin Ilham, S.KM
5	12.20-12.25 WIB	5 menit	Penutupan dan post-test	SDM
6	12.25-12.30 WIB	5 menit	Absensi kedua by fingerprint	SDM

2.6 Narasumber / Pemateri

1. Faisal Aminuddin Ilham, S.KM

2.7 Media

1. LCD
2. Laptop
3. Sound System

2.8 Metode

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya Jawab



2.9 Kebutuhan Anggaran

NO	DESKRIPSI	JUMLAH SATUAN	TOTAL
1	Fee untuk pemateri	0	0
2	Konsumsi pemateri dan panitia	1 nasi kotak (Rp.15.000,-) x 2 panitia	Rp.30.000,-
	Konsumsi peserta	Air mineral + kue dari dapur	0
3	Sertifikat	Soft copy	0
Total Biaya			Rp.30.000,-

III. MONITORING – EVALUASI

3.1 Monitoring

Monitoring dilakukan selama kegiatan berlangsung

3.2 Evaluasi

Evaluasi diklat dilakukan oleh kepala ruang masing – masing dan disupervisi oleh Komite K3RS

IV. PENUTUP

Demikian TOR ini kami buat sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan ini. Suksesnya acara ini memerlukan dukungan dan kerjasama dari seluruh staf yang ada dan agar tujuan orientasi tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Malang, 25 Maret 2025

SDM RS Prima Husada

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

**Annadiva Fikri Chandra
Maulana, S.Psi**

Ketua Panitia

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Faisal Aminuddin Ilham, S.KM

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah



MATERI PELATIHAN
Cara Perhitungan Nilai Grading Risiko

1. P (PROBABILITY / (PELUANG RISIKO AKAN TERJADI))

(Jumlah Angka (1 s/d 5) Risiko Kemungkinan Terjadi dalam Setahun)

ex risiko (peluang terjadi) terjatuh bisa 1 sampai 5 kali dalam setahun

Probabilitas
Sangat sering terjadi (Tiap minggu/bulan)
5
Sering Terjadi (Beberapa kali/tahun)
4
Mungkin terjadi (1-<2 tahun/kali)
3
Jarang terjadi (>2-<5 tahun/kali)
2
Sangat jarang terjadi (>5tahun/kali)
1

2. D (DAMPAK YANG TERJADI)

(Dampak Risiko (Nilai 1 s/d 5) yang Ditimbulkan)

ex risiko (frekuensi terjadi) terjatuh bisa 1 sampai 5 kali dalam setahun

Sangat sering terjadi (Tiap minggu/bulan)
5
Sering Terjadi (Beberapa kali/tahun)
4
Mungkin terjadi (1-<2 tahun/kali)
3
Jarang terjadi (>2-<5 tahun/kali)
2
Sangat jarang terjadi (>5tahun/kali)
1



Tingkat Risiko	Deskripsi	Dampak
1	Tidak signifikan	Tidak ada cedera
2	Minor	- Cedera ringan mis. Luka lecet - Dapat diatasi dengan pertolongan pertama.
3	Moderat	- Cedera sedang mis. Luka robek - Berkurangnya fungsi motorik/sensorik/ psikologis atau intelektual (reversibel), tidak berhubungan dengan penyakit. - Setiap kasus yang memperpanjang perawatan
4	Mayor	- Cedera luas / berat misal cacat, lumpuh - Kehilangan fungsi motorik/sensorik/psikologis atau intelektual (irreversibel), tidak berhubungan dengan penyakit.
5	Katastropik	Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit

(Hasil dikalikan semua) = P (Probaility) x D (Dampak)

Contoh Studi Kasus :

Sedang dilakukan tindakan operasi pasien di IKO, tiba – tiba mesin Anestesi berhenti, rusak / tidak dapat dipergunakan (dikarenakan kegagalan alat medis / kegagalan utilitas), sehingga berisiko terhadap keselamatan pasien,

Hasil analisa :

- Nilai **P** nya adalah 4 (mungkin besar), karena kegiatan operasi dilakukan setiap hari, setiap saat)
- Nilai **D** nya adalah 5 (kastropik, risiko kematian)

Jadi = P x D = 4 x 5 = **20** (nilai risiko tinggi, **merah**, risiko kematian pasien)

Contoh Hasil Nilai Grading Risiko Matriks

Matriks Analisa Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Katastrophe
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti	9	15	18	23	25
	4	Kemungkinan Besar	6	12	16	19	24
	3	Mungkin	4	10	14	17	22
	2	Jarang	2	7	11	13	21
	1	Sangat Jarang	1	3	5	8	20

1. Biru : Tidak ada cedera
2. Hijau : Risiko cidera ringan
3. Kuning : Risiko cidera sedang
4. Orange : Risiko menyebabkan cacat
5. Merah : Risiko menyebabkan kematian